

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

**DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT
THERAPEUTISCHE MONITORING
ENQUETE 2026/1**

* KB 03/12/1999

Sciensano/THER.MON./71/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano					
Secretariaat		TEL:	02/642.55.22	FAX:	02/642.56.45
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be		
VANTORRE Audrey	Coördinator	TEL:	02/642.57.55		
		E-mail:	audrey.vantorre@sciensano.be		
LENGA Yolande	Vervanger coördinator	TEL:	02/642.53.96		
		E-mail:	yolande.lenga@sciensano.be		
Experten	Instelling				
Apr. Klin. Biol. Croes Kathleen	AZ Groeninge				
Apr. Klin. Biol. Haufroid Vincent	Cliniques universitaires Saint-Luc				
Apr. Klin. Biol. Van den Eede Nele	UZ Leuven				
Apr. Klin. Biol. Catry Emilie	CHU UCL Namur – UCLouvain				
Apr. Klin. Biol. De Keukeleire Steven	RZ Tienen				
Dr. Dubois Nathalie	CHU Liège				
Apr. Klin. Biol. Oyaert Matthijs	Uz Gent				
Apr. Klin. Biol. Piqueur Marian	ZAS				

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op: 15/05/2026
Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experts van: 22/05/2026

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de Therapeutische Monitoring-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door A.Vantorre, coördinator.

Publicatiedatum : 29/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-therapeutische-drug-monitoring>

INHOUDSTAFEL

CONVERSIETABEL – THERAPEUTISCHE MONITORING	4
INLEIDING	5
HOMOGENITEIT VAN DE STALEN	5
STABILITEIT VAN DE STALEN	5
TARGETWAARDE.....	5
UPDATING KITS.....	5
VERVALLEN KITS.....	5
OP WELKE MANIER KUNNEN DE GECENSUREERDE WAARDEN (< OF > DAN DE DREMPELWAARDE) INGEGEVEN WORDEN IN DE TOOLKIT ?	6
TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE RAPPORTEN.....	6
INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT	7
ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE.....	10
INFORMATIE VERMELD IN DE TOOLKIT	10
AARD VAN DE STALEN	10
RUWE DATA.....	10
CARBAMAZEPINE	12
DIGOXINE	13
GENTAMICINE.....	15
PARACETAMOL	16
FENYTOINE	17
VALPROINEZUUR	18
VANCOMYCINE.....	19

CONVERSIETABEL – THERAPEUTISCHE MONITORING

AMIKACINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.58	⇒	
CARBAMAZEPINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.24	⇒	
DIGOXINE	µg/L	x	1.00	⇒	µg/L
	ng/mL	x	1.00	⇒	
	nmol/L	x	0.78	⇒	
GENTAMICINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.48	⇒	
LITHIUM	mmol/L	x	1.00	⇒	mmol/L
	mEq/L	x	1.00	⇒	
PARACETAMOL	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.15	⇒	
FENYTOÏNE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.25	⇒	
SALICYL ZUUR	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	mmol/L	x	138.12	⇒	
VALPROINEZUUR	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	0.14	⇒	
VANCOMYCINE	mg/L	x	1.00	⇒	mg/L
	µg/mL	x	1.00	⇒	
	µmol/L	x	1.45	⇒	

INLEIDING

Homogeniteit van de stalen

De homogeniteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Stabiliteit van de stalen

De stabiliteit van het staal werd gecertificeerd door de firma Randox.

Targetwaarde

De targetwaarde is de mediaan van de methode indien het aantal resultaten voor deze methode hoger of gelijk is aan 6. Als het aantal deelnemers <6 is, wordt de groep niet geëvalueerd. Als het aantal gecensureerde waarden te hoog is, wordt er ook geen Z-score berekend.

Updating kits

Om de juistheid van de resultaten van de externe kwaliteitscontrole te verzekeren, is het belangrijk dat alle informatie met betrekking tot de methode en de gebruikte kits correct is. Wij stellen bij elke enquête vast dat een klein aantal laboratoria de juistheid van deze informatie vergeet te controleren. Indien u uw kit niet terugvindt in de toolkit, aarzel dan niet om ons zo vlug mogelijk te contacteren of een e-mail te sturen met in bijlage een scan van de bijsluiter van uw kit op het volgende adres: audrey.vantorre@sciensano.be.

Vervallen kits

Wanneer een bepaalde kit niet meer wordt gecommercialiseerd en de einddatum (vervaldatum) wordt bereikt, verdwijnt deze kit uit de toolkit. Een waarschuwingsbericht verschijnt op het scherm: « Uw kit is vervallen. Gelieve uw nieuw catalogusnummer in te voeren ». Het is dus noodzakelijk dat u de nieuwe kit herparametreert, **zelfs indien het enkel om een verandering van het catalogusnummer gaat**. Voor alle methodes die « kit afhankelijk » zijn, wordt het principe van de methode automatisch toegekend.

Op welke manier kunnen de gecensureerde waarden (< of > dan de drempelwaarde) ingegeven worden in de toolkit ?

Voorbeeld voor het ingeven van gegevens:

DIGOXINE

Kit ABBOTT Digoxin (1P32 - 25)

Methode immunoassay, chemical marker, luminescence

Meetapparaat ABBOTT Architect i2000SR

Parameterdefinitie voor DIGOXINE

Resultaat (Operator+waarde+eenheid) < µg/L

Vrije tekst

De tekens « > » en « < » bevinden zich juist **voor** het vakje waar het **kwantitatieve resultaat** wordt ingegeven.

Ter beschikking stellen van de rapporten

Wij vragen u om uw antwoorden binnen de gestelde termijn terug te sturen zodat de resultaten voor de laboratoria, onder de vorm van een eerste niet-gevalideerde individueel rapport, zo vlug mogelijk na het afsluiten van de enquête beschikbaar zijn. Voor die laboratoria waarvoor omwille van onvoorziene omstandigheden voor een bepaalde enquête er een probleem zou zijn voor de tijdslimiet, kan de toegang tot de toolkit uitzonderlijk worden verlengd. Dit vertraagt echter de productie van de rapporten voor het geheel van de groep. In eenieders voordeel vragen wij u dus om aandachtig te zijn en de voorgestelde termijnen te respecteren. Eenmaal de niet-gevalideerde individuele rapporten toegankelijk zijn, beschikt u over 7 dagen om ons uw eventuele opmerkingen mee te delen. Wij wensen de laboratoria er op te wijzen hun resultaten na het ingeven goed na te kijken (cfr. manuele ingave tijdens routine analyses) om het aantal fouten (eenheden, andere,...) tot een minimum te herleiden. Indien u ondanks alles, toch nog een fout vaststelt op uw niet-gevalideerd individueel rapport, gelieve ons dit te melden.

Na de validatie van de enquête door het Comité van experts is het definitief globaal rapport beschikbaar op onze website op het volgende adres:

<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria/eke-therapeutische-drug-monitoring>

INTERPRETATIE VAN HET INDIVIDUELE RAPPORT

Naast dit globale rapport, heeft u ook toegang tot een individueel rapport via de toolkit.

Hieronder vindt u informatie, die u kan helpen om dit rapport te interpreteren.

De positie van uw kwantitatieve resultaten wordt enerzijds gegeven in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers en anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken.

De volgende informatie wordt gegeven:

- Uw resultaat (R)
- Uw methode
- De globale mediaan (M_G):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale standaarddeviatie (SD_G):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door alle laboratoria voor alle methodes samen.
- De globale mediaan van uw methode (M_M):
de centrale waarde van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De standaarddeviatie van uw methode (SD_M):
maat voor de spreiding van de resultaten bekomen door de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken.
- De variatiecoëfficiënt CV (uitgedrukt in %) voor alle laboratoria en voor de laboratoria die dezelfde methode als u gebruiken:
 $CV_M = (SD_M / M_M) * 100 (\%)$ en $CV_G = (SD_G / M_G) * 100 (\%)$.
- De Z-score:
het verschil tussen uw resultaat en de mediaan van uw methode (uitgedrukt als een veelvoud van de SD): $Z_M = (R - M_M) / SD_M$ en $Z_G = (R - M_G) / SD_G$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|Z_M| > 3$.
- De U-score:
de relatieve afwijking van uw resultaat t.o.v. de mediaan van uw methode (uitgedrukt in %):
 $U_M = ((R - M_M) / M_M) * 100 (\%)$ and $U_G = ((R - M_G) / M_G) * 100 (\%)$.
Het resultaat wordt geciteerd indien $|U_M| > d$, waarbij “d” de vaste limiet is van de betrokken parameter, met name het % maximaal toegelaten afwijking t.o.v. de mediaan van de methode.
- Een grafische interpretatie van de positie van uw resultaat (R), enerzijds in vergelijking met alle resultaten van alle deelnemers, anderzijds in vergelijking met de resultaten van de deelnemers die dezelfde methode als u gebruiken, gebaseerd op de methode van Tukey, voor elke parameter en voor elk geanalyseerd staal.

R : uw resultaat

$M_{M/G}$: mediaan

$H_{M/G}$: percentielen 25 en 75

$I_{M/G}$: interne limieten ($M \pm 2.7 SD$)

$O_{M/G}$: externe limieten ($M \pm 4.7 SD$)

De globale grafiek en deze van uw methode worden uitgedrukt volgens dezelfde schaal, op deze wijze zijn beide vergelijkbaar. Deze grafieken geven u een ruw geschatte indicatie van de positie van uw resultaat (R) t.o.v. de medianen ($M_{M/G}$).

U kan meer details vinden in de brochures die beschikbaar zijn op onze website op het volgende adres:

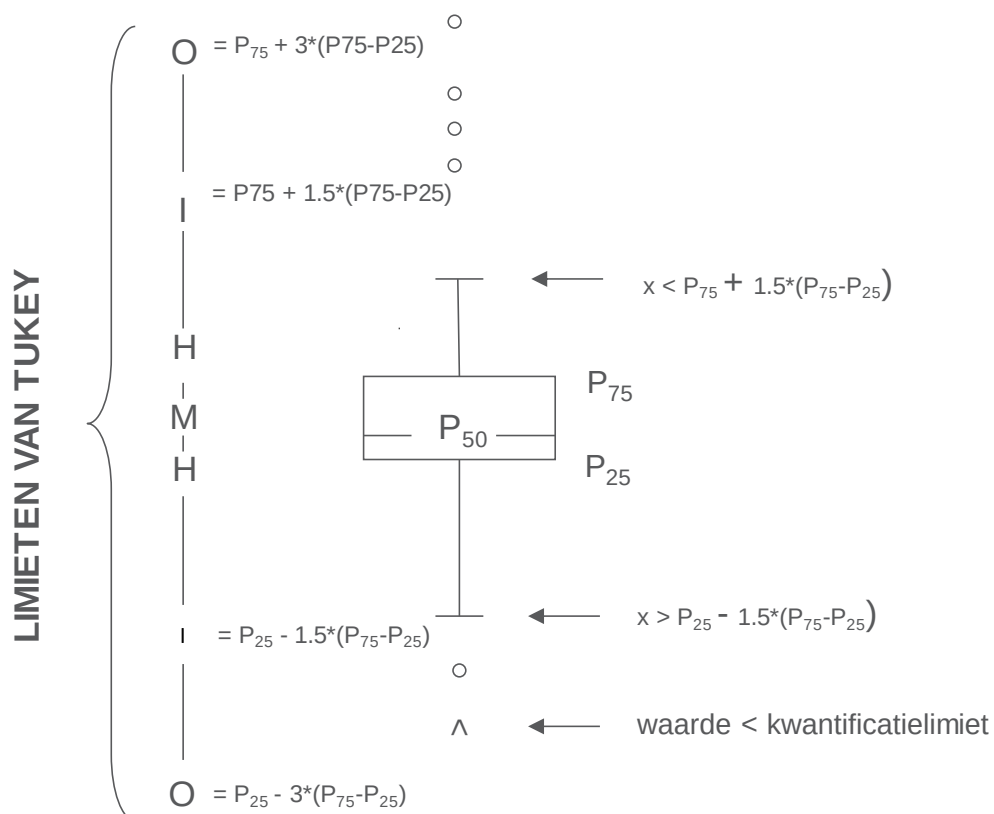
[Klinische gezondheid | EKE klinische biologie | sciensano.be](#)

- [Algemene informatiebrochure EKE](#)
- [Statistische methoden gebruikt voor EKE](#)
- [Verwerking van gecensureerde waarden](#)

Grafische voorstelling

Naast de tabellen met de resultaten, wordt er soms een grafische voorstelling van de resultaten als een “box en whisker plot” toegevoegd. Deze bevat de volgende elementen voor methoden met minstens 6 deelnemers:

- een rechthoek die gaat van percentiel 25 (P_{25}) tot percentiel 75 (P_{75})
- een centrale lijn die de mediaan van de resultaten voorstelt (P_{50})
- een ondergrens die de kleinste waarde voorstelt $x > P_{25} - 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- een bovengrens die de grootste waarde voorstelt $x < P_{75} + 1.5 * (P_{75} - P_{25})$
- alle punten buiten dit interval worden voorgesteld door een cirkel.



Overeenkomstige limieten in geval van een normale verdeling

ENQUÊTE SPECIFIEKE INFORMATIE

Het staal voor de enquête 2026/1 werd op 02/02/2026 verstuurd. De afsluitdatum voor het ingeven van de resultaten was 16/02/2026. Vanaf 26/02/2026 waren de niet-gevalideerde individuele rapporten beschikbaar in de toolkit. De validatie gebeurde op 29/05/2026. Vanaf deze datum zijn de definitieve individuele rapporten beschikbaar via de toolkit. Dit rapport was beschikbaar op onze website op 29/05/2026.

Informatie vermeld in de toolkit

Gelieve de analyses zo vlug mogelijk na ontvangst uit te voeren of ten laatste op 06/02/2026.

Bewaar de fles bij 2 tot 8 °C.

R/22041 : Behandel dit product op dezelfde manier als patiënten stalen.

Laat het product op kamertemperatuur komen (15 tot 25 °C) alvorens de analyse uit te voeren. Schud de fles voorzichtig om de homogeniteit te verzekeren. Vermijd schuimvorming. Plaats na elk gebruik onmiddellijk de stop terug.

Dit staal is tevens bestemd voor de EKE Immunoassays en Cardiale Merkers 2026/1.

Aard van de stalen

Ter gelegenheid van deze enquête 2026/1 werd een vloeibaar ingevroren staal (4mL) van de firma Randox naar alle deelnemers verstuurd: Namelijk staal **R/22041**.

Ruwe data

De geanonimiseerde ruwe data zijn ter beschikking op aanvraag bij audrey.vantorre@sciensano.be.

Voorwoord

Wanneer de analytische variabiliteit van een bepaalde methode voor een bepaalde parameter laag is in vergelijking met de historiek van onze gegevensdatabase, wordt een herberekening van de basisstatistiek uitgevoerd na verwijdering van uitschieters, indien aanwezig, ten einde na te gaan of de foutieve geciteerde resultaten voor de Z-evaluatie gerecupereerd kunnen worden. Het is een extra stap om de laboratoria beter te kunnen beoordelen. Het is ook aan het labo zelf om een kritische analyse uit te voeren van zijn eigen citaties. De post-hoc analyse van de stabiliteit van de stalen op basis van de bekomen resultaten van de deelnemers kan leiden tot het niet evalueren van een parameter indien dit nodig wordt geacht.

Naar aanleiding van de resultaten van de **lage variabiliteitsstudie** zijn **enkele aanpassingen doorgevoerd aan de rapporten van de EKE Therapeutische Drug Monitoring 2026/1**.

Gelieve deze **wijzigingen aandachtig te raadplegen** en te controleren of deze invloed hebben gehad op uw individueel rapport.

Stabiliteitsstudie:

Op basis van de resultaten van de deelnemers voert Sciensano een post-analyse uit voor de homogeniteit en stabiliteit van de stalen. Indien de stabiliteitsanalyse aantoont dat de resultaten van een parameter niet voldoen aan de vereisten, omwille van een trend waarbij de Z-citaties toenemen afhankelijk van de dag van analyse, kan dit leiden tot het niet evalueren van deze parameter.

De resultaten van de parameters weergegeven in onderstaande tabel voldoen niet aan de stabiliteitsvereisten en worden **bijgevolg niet geëvalueerd**.

Mocht u een van deze parameters hebben gerapporteerd, dan worden deze niet langer beoordeeld:

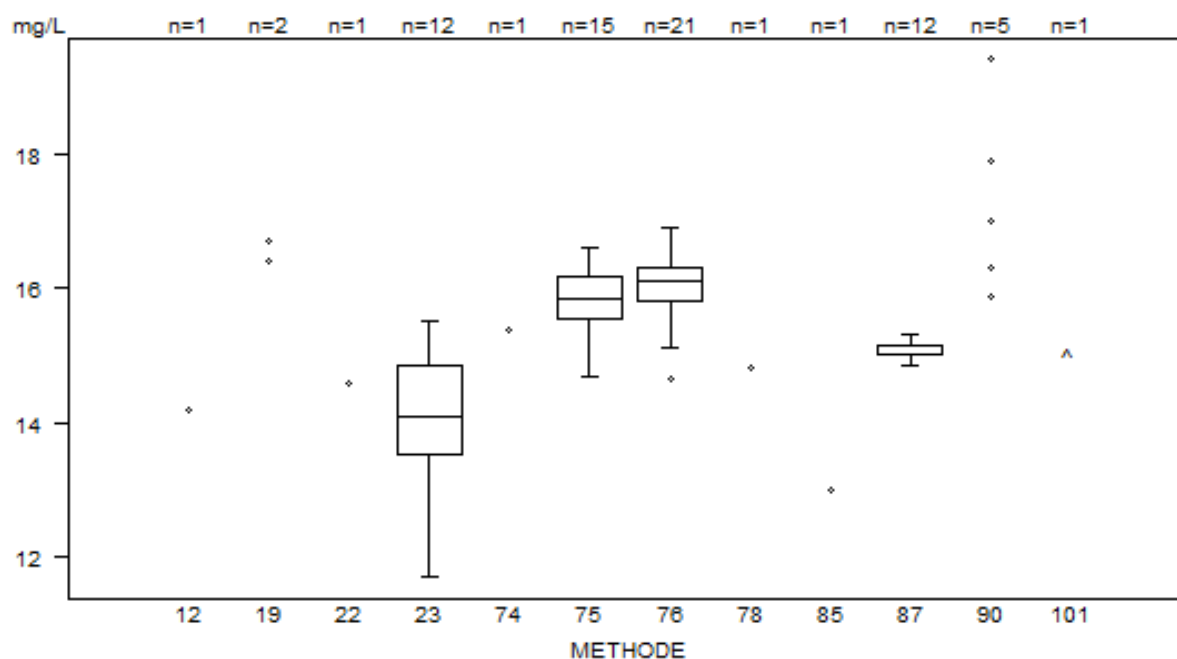
Staal	Parameter	P-waarde voor Z-scores (Spearman-correlatie)	P-waarde voor U-scores (Spearman-correlatie)
R/22041	Digoxine	0.0359	0.1732
R/22041	Vancomycine	0.0071	9×10^{-4}

Lage variabiliteitsstudie:

Naar aanleiding van de resultaten van de lage variabiliteitsstudie werden **voor alle parameters de robuuste standaardafwijking**, die gewoonlijk wordt gebruikt voor EKE-berekeningen, **behouden** voor alle referentiegroepen.

CARBAMAZEPINE

CARBAMAZEPINE - d (%) : 12.0		R/22041			
METHODE		Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
012 High Performance Liquid Chromatography		14.2			1
019 Abbott - Architect - Immunoassay - Chemiluminescence		16.4	16.7		2
022 Abbott - Architect - PETINIA		14.6			1
023 Abbott Alinity		14.1	1.0	7.0	12
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS		15.4			1
075 Roche / Hitachi cobas c - Gen.4		15.8	0.5	2.9	15
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703/ Pro/ Pure		16.1	0.4	2.3	21
078 Thermo Scientific - CEDIA		14.8			1
085 Siemens Immulite		13.0			1
087 Siemens Atellica CH		15.0	0.1	0.7	12
090 OCD Vitros		15.9 17.9	16.3 19.4	17.0	5
101 LC-MS/MS		> 15.0			1
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)		15.7	0.9	5.7	73



Aantal citaties voor de bepaling van Carbamazepine: Staal R/22041

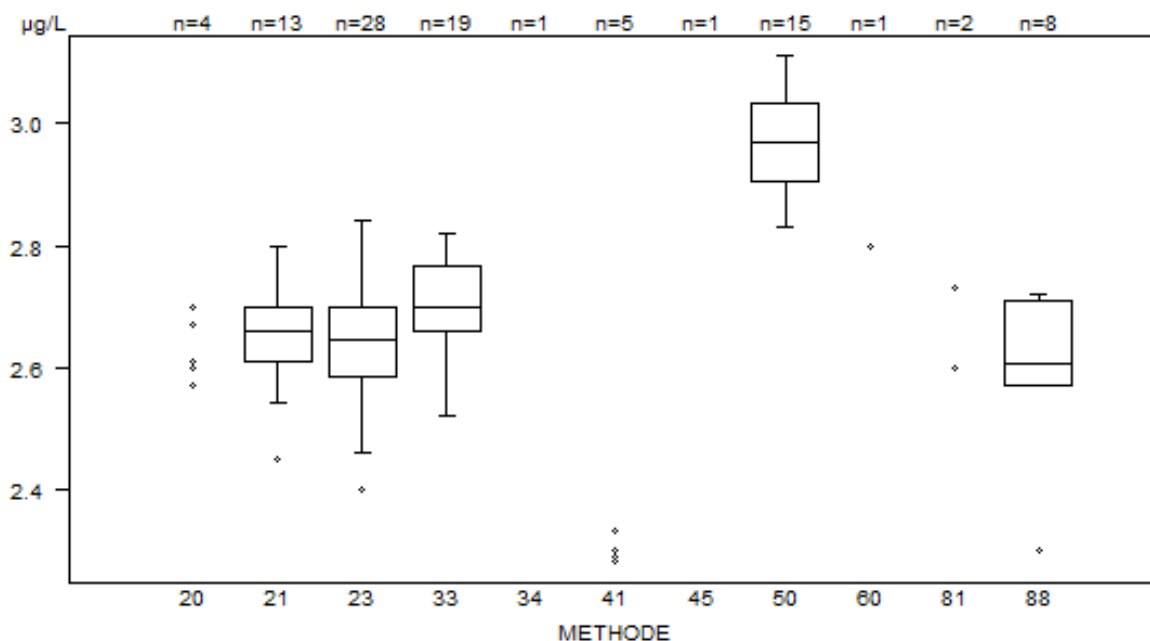
Methode	Z-citatie	U-citatie
023 Abbott Alinity	0	1
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703/ Pro/ Pure	1	0

* dCarbamazepine: 12%

DIGOXINE

DIGOXINE - d (%) : 17.0	R/22041			
METHODE	Median µg/L	SD µg/L	CV %	N
020 Roche/Hitachi - cobas c 701/702	2.57 2.70	2.60	2.61	4
021 Roche/Hitachi - cobas c 501	2.66	0.07	2.5	13
023 Roche - Elecsys cobas e 801	2.65	0.09	3.2	28
033 Abbott Alinity	2.70	0.08	2.9	19
034 Abbott Architect	1.90			1
041 OCD Vitros	2.11 2.30	2.28 2.33	2.29	5
045 Siemens Atellica CH	3.20			1
050 Siemens - Atellica	2.97	0.09	3.2	15
060 Olympus	2.80			1
081 Beckman Coulter Access	2.60 2.73			2
088 Roche Elecsys Modular E Cobas e	2.61	0.10	4.0	8
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	2.70	0.15	5.5	97

De analyse van de stabiliteit van de resultaten van Digoxine die in deze enquête zijn verkregen voor staal R/22041, voldoet niet. Er is een tendens vastgesteld waarbij de Z-scores toenemen met de dag van analyse (Spearman correlatie, Pz-scores waarde = 0.0359 en Pu-scores waarde = 0.1732). Deze parameter wordt bijgevolg niet geëvalueerd.



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
034 = 1.9 µg/L
041 = 2.11 µg/L
021 = 3.3 µg/L
045 = 3.2 µg/L
088 = 3.4 µg/L

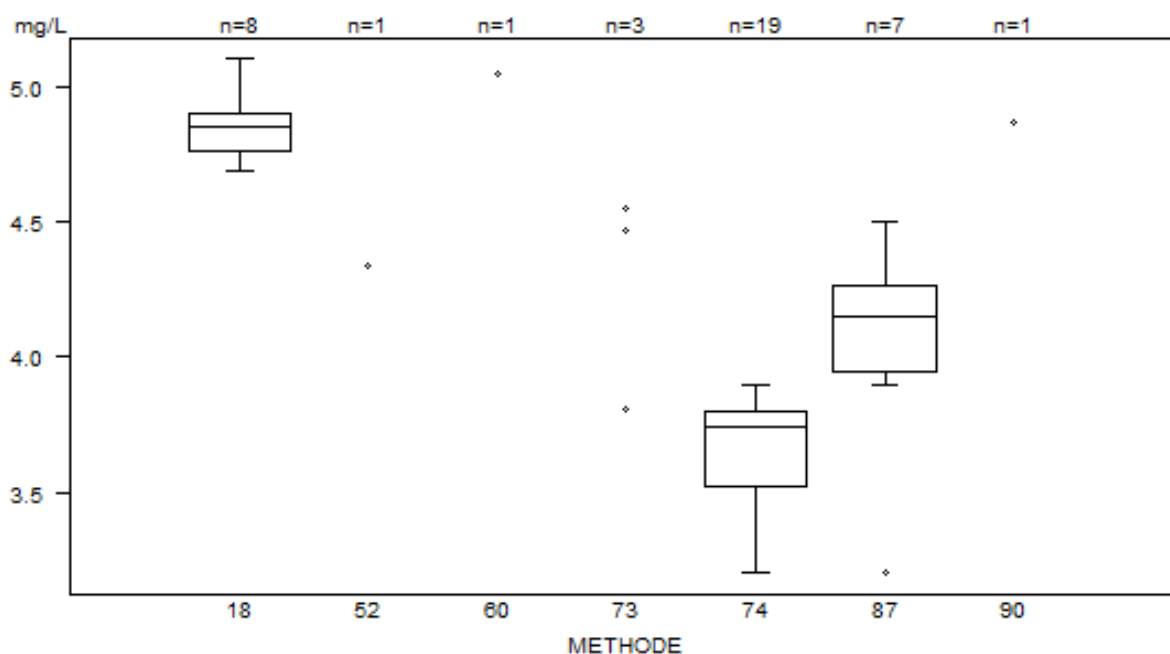
Aantal citaties voor de bepaling van Digoxine: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
021 Roche/Hitachi - cobas c 501	2	1
023 Roche - Elecsys cobas e 801	0	0

* dDigoxine: 17%

GENTAMICINE

GENTAMICINE - d (%) : 18.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
018 Abbott Alinity	4.85	0.11	2.2	8
052 Microgenics	4.34			1
060 Olympus	5.05			1
073 Roche/Hitachi - CEDIA	3.81	4.47	4.55	3
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS	3.74	0.20	5.5	19
087 Siemens Atellica CH	4.15	0.23	5.5	7
090 OCD Vitros	4.87			1
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	3.90	0.67	17.1	40



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat
74 = 2.8 mg/L

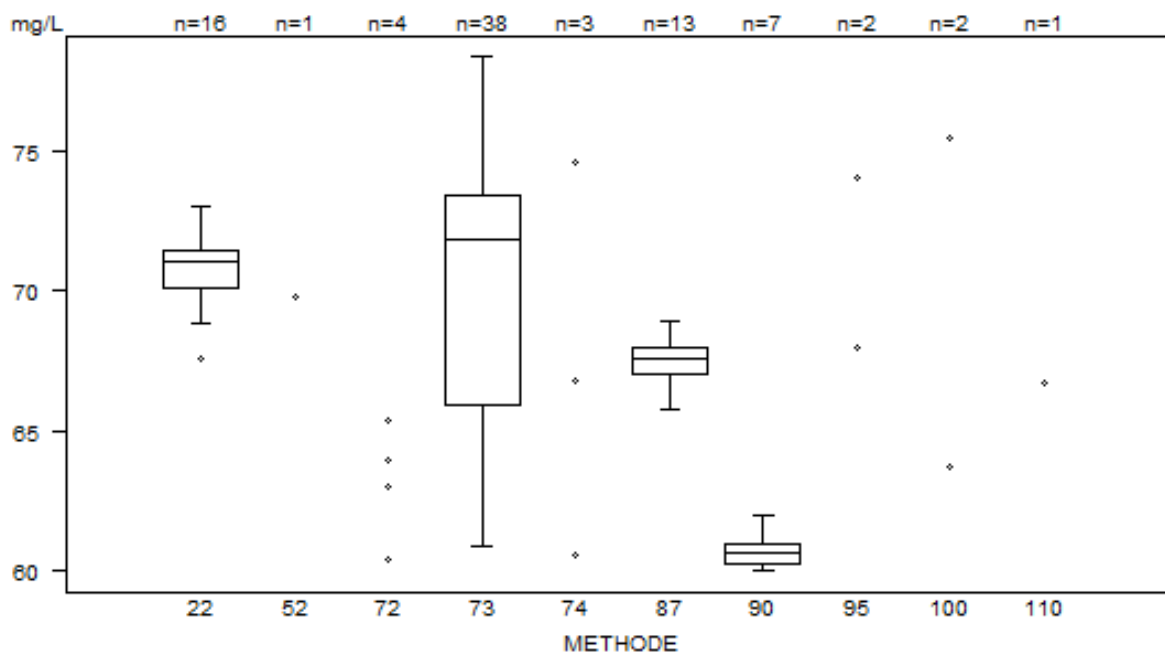
Aantal citaties voor de bepaling van Gentamicine: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
074 Roche / Hitachi Mod. cobas c - KIMS	1	1
087 Siemens Atellica CH	1	1

* dGentamicine: 18%

PARACETAMOL

PARACETAMOL - d (%) : 13.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
022 Abbott	71.1	1.0	1.4	16
052 Microgenics - Immunoenzymatic assay - Spectrometry	69.8			1
072 Roche Cobas Integra - cobas c	60.4 65.4	63.0	64.0	4
073 Roche/Hitachi cobas c (2nd gen.)	71.8	5.6	7.7	38
074 Roche - Hitachi Modular	60.6	66.8	74.6	3
087 Siemens Atellica CH	67.6	0.7	1.1	13
090 OCD Vitros	60.7	0.6	0.9	7
095 Sekisui Diagnostics - Abbott	68.0	74.0		2
100 Siemens Emit - Beckman Coulter AU	63.7	75.4		2
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	69.5	4.7	6.8	87



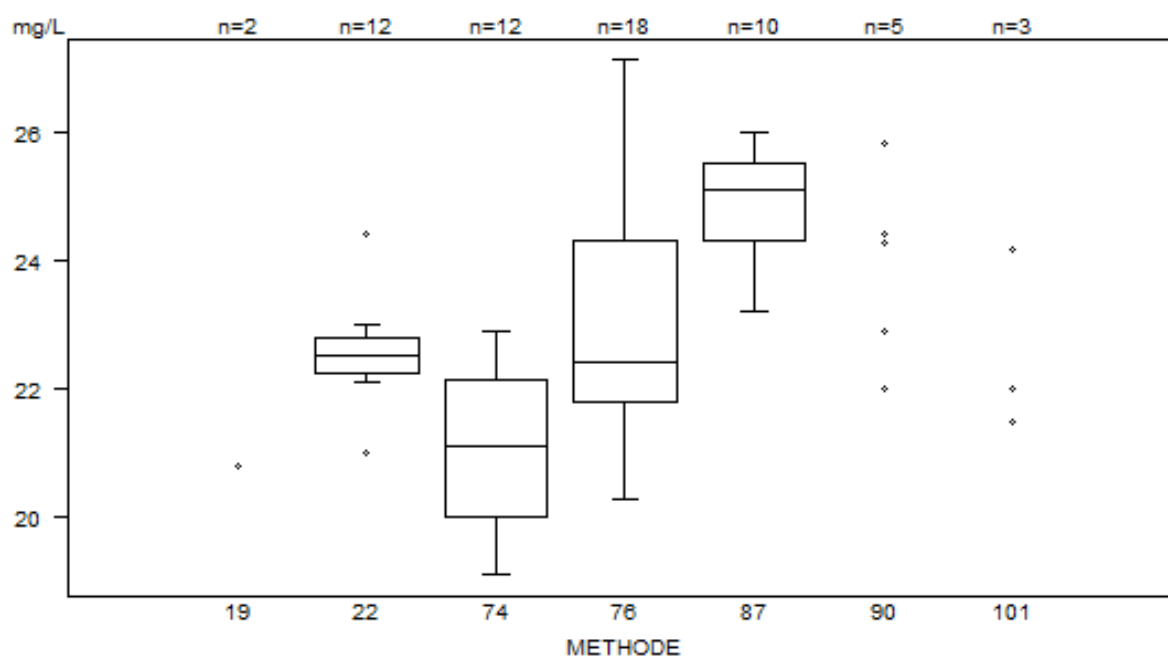
Aantal citaties voor de bepaling van Paracetamol: Staal R/22041

Methode	Z-citatie
022 Abbott	1

* dParacetamol: 13%/ ± 4.62 mg/L

FENYTOINE

FENYTOINE - d (%) : 16.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
019 Abbott Architect - Chemiluminescence	17.8 20.8			2
022 Abbott Alinity	22.5	0.4	1.8	12
074 Roche / Hitachi Mod cobas c	21.1	1.6	7.5	12
076 Roche / Hitachi cobas c 503	22.4	1.9	8.3	18
087 Siemens Atellica CH	25.1	0.9	3.5	10
090 OCD Vitros	22.0 24.4	22.9 25.8	24.3	5
101 LC-MS/MS	21.5	22.0	24.2	3
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	22.5	1.9	8.6	62



Data buiten de grafiek
Methode Resultaat
19 = 17.8 mg/L

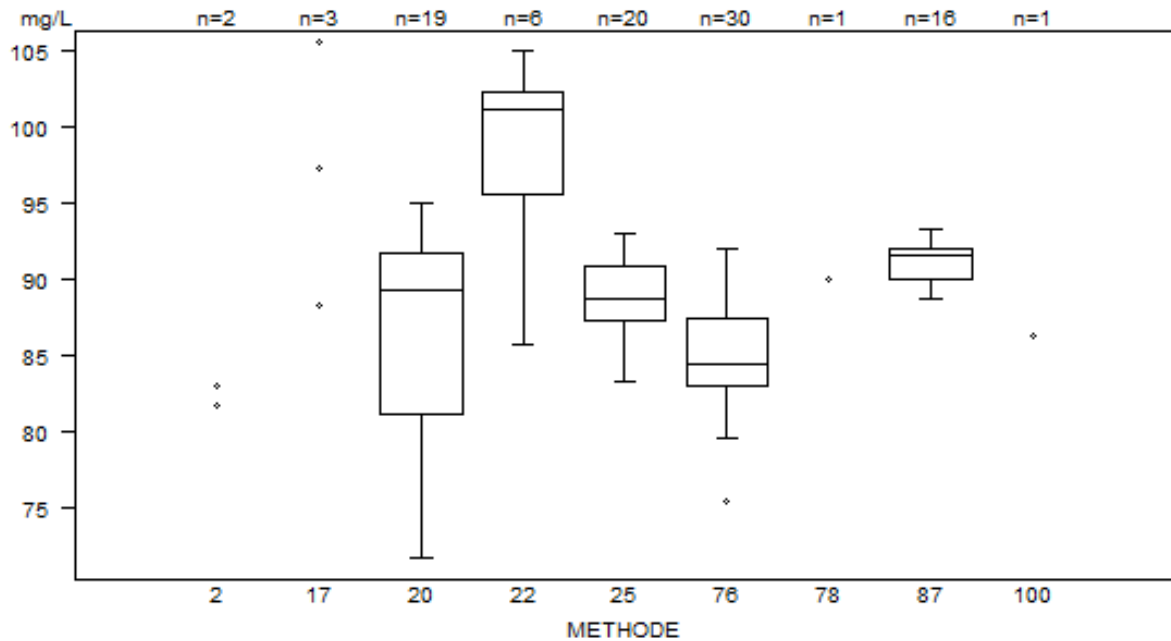
Aantal citaties voor de bepaling van Fenytoine: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
022 Abbott Alinity	2	0
076 Roche / Hitachi cobas c 503	0	1

* dFenytoine: 16%

VALPROINEZUUR

VALPROINEZUUR - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
002 Abbott Architect - CMIA	81.8	83.0		2
017 Olympus	88.3	97.4	105.6	3
020 Roche Hit / Mod / cobas c	89.3	7.9	8.8	19
022 OCD Vitros	101.2	5.0	4.9	6
025 Abbott Alinity	88.7	2.7	3.0	20
076 Roche / Hitachi cobas c 503/ c 703 / Pro / Pure	84.4	3.3	3.9	30
078 Thermo Scientific - CEDIA	90.0			1
087 Siemens Atellica CH	91.6	1.4	1.6	16
100 LC-MS	86.3			1
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	88.4	5.3	6.0	98



Aantal citaties voor de bepaling van Valproïnezuur: Staal R/22041

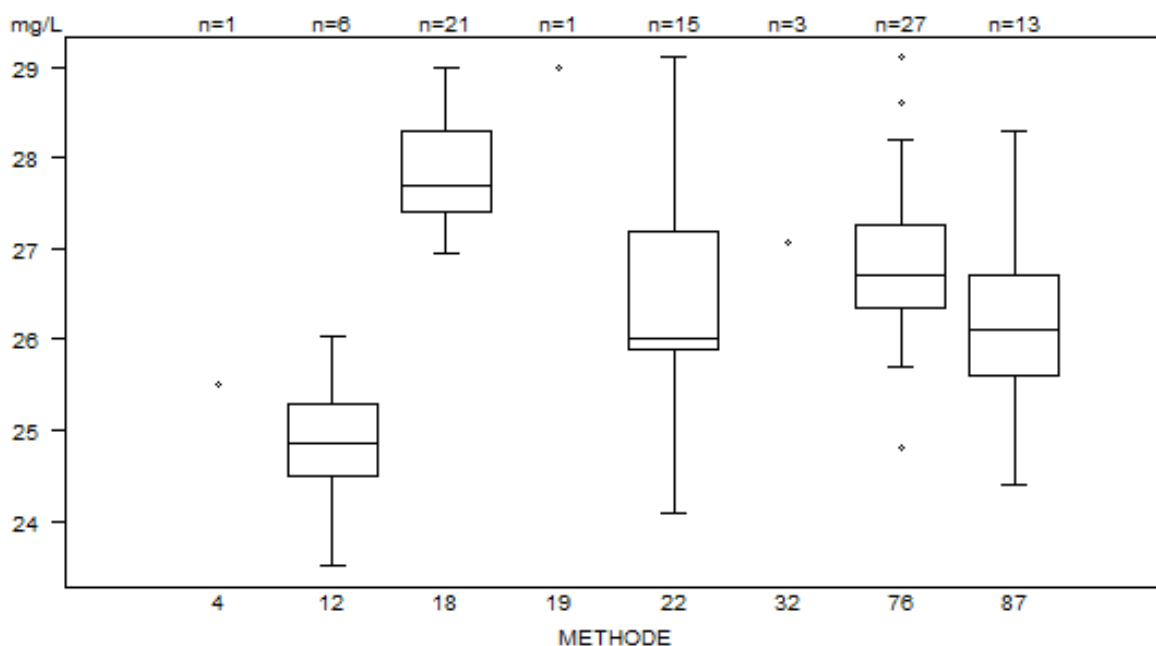
Methode	Z-citatie	U-citatie
020 Roche Hit / Mod / cobas c	0	2
022 OCD Vitros	1	1

* dValproïnezuur: 12%

VANCOMYCINE

VANCOMYCINE - d (%) : 12.0	R/22041			
METHODE	Median mg/L	SD mg/L	CV %	N
004 Beckman Coulter - Emit	25.5			1
012 OCD Vitros	24.9	0.6	2.4	6
018 Abbott Alinity	27.7	0.7	2.4	21
019 Abbott Architect	29.0			1
022 Roche/Hitachi cobas c - Integra (Gen.3)	26.0	1.0	3.7	15
032 Thermo Scientific	22.7	27.1	30.1	3
076 Roche / Hitachi cobas c 503	26.7	0.7	2.5	27
087 Siemens Atellica CH	26.1	0.8	3.1	13
Globale resultaten (alle methoden en alle meetsystemen)	27.0	1.3	4.7	87

De analyse van de stabiliteit van de resultaten van Vancomycine die in deze enquête zijn verkregen voor staal R/22041, voldoet niet. Er is een tendens vastgesteld waarbij de Z-scores toenemen met de dag van analyse (Spearman correlatie, Pz-scores waarde = 0.0071 en Pu-scores waarde = 9×10^{-4}). Deze parameter wordt bijgevolg niet geëvalueerd.



Data buiten de grafiek

Methode Resultaat

32 = 22.7 mg/L

32 = 30.1 mg/L

Aantal citaties voor de bepaling van Vancomycine: Staal R/22041

Methode	Z-citatie	U-citatie
022 Roche/Hitachi cobas c - Integra (Gen.3)	1	0
076 Roche / Hitachi cobas c 503	1	0

* dVancomycine: 12%

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experts of de werkgroep EKE.